Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent9vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5116746-32.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: SONIA MARIA PALLAORO MOOJEN

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos

SONIA MARIA PALLAORO MOOJEN ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência e ressarcimento em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.** Narrou que possui contrato coletivo empresarial ativo, firmado pela UFRGS com a demandada, desde 10/08/2010. Informou que, em novembro de 2020 seu hemograma apresentou sinais de recidiva de leucemia mieloide aguda, detectada em 2018 (CID C92.0), sendo necessário o uso contínuo do medicamento Glivec Imatinibe - 100mg, inicialmente na dosagem de 120 comprimidos ao mês, e, a partir de janeiro de 2022, 180 comprimidos ao mês, que totalizava o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensalmente. Discorreu sobre o direito que lhe assiste, salientando o laudo que informava que o resultado inicial indicava progressiva melhora do quadro clínico com uso da medicação, desde novembro de 2021 – com diminuição progressiva das células malignas da circulação. Informou que pleiteou, administrativamente, no dia 14/12/2021, o fornecimento junto à ré, obtendo a negativa desta. Aduziu que o medicamento estava expressamente elencado no rol de cobertura obrigatória da requerida. Colacionou jurisprudência. Requereu, em tutela de urgência, que a ré fosse compelida a fornecer o medicamento referido imediatamente à autora, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, enquanto perdurasse a necessidade/prescrição. No mérito, pleiteou pela procedencia da ação, para condenar a ré a fornecer o medicamento à autora enquanto fosse necessário, bem como condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais havidos com a compra do medicamento, desde a solicitação (14/12/2021) até o efetivo fornecimento. Anexou procuração e documentos.

As custas foram recolhidas, evento 29, CUSTAS2.

A tutela de urgência foi deferida evento 18, DESPADEC1.

Citada, a ré apresentou contestação evento 30, CONT1. Preliminarmente, impugnou o valor da causa e referiu pedido indeterminado pela autora, quanto aos valores pretendidos a título de reembolso. No mérito, asseverou que não era obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existia, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Discorreu sobre o rol taxativo da ANS. Mencionou sobre a ausência de previsão contratual e legal para fornecimento de medicação *off-label (experimental)*. Afirmou que a medicação possui previsão na diretriz do plano, porém diverge do uso para a doença apontada pela autora. Dissertou sobre a legislação que trata do tema e colacionou jurisprudência. Insurgiu-se ao reembolso dos valores despendidos pela requerente. Postulou a improcedência dos pedidos. Anexou procuração e documentos.

Sobreveio réplica, evento 34, RÉPLICA1.

Instadas as partes acerca do interesse na produção de provas suplementares, nada requereram, evento 36, DESPADEC1.

A autora peticionou, informando que, previamente à concessão da tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento pela ré, foram adquiridas 8 caixas do medicamento, acostando as notas fiscais de compra (Evento 40).

Vieram, os autos, conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação em que a parte autora postula o fornecimento e disponibilização pela requerida de medicação para tratamento de leucemia mieloide aguda CID C92.0 (Imatinibe - 100mg), conforme prescrição medica, bem como o ressarcimento do montante já despendido pelo medicamento desde a solicitação administrativa, até o fornecimento pela ré, quando acolhida a tutela de urgência.

Quanto a preliminar aventada de impugnação ao valor da causa, digo que não merece prosperar.

Explico: Em sede de réplica, a autora justifica a atribuição ao valor da causa correspondente ao montante do **custo anual para a aquisição do medicamento**, utilizando-se, como base de cálculo, o orçamento de menor valor, entendimento pacificado sob a ótica trazida pela autora.

Ademais, as demandas que possuem como objeto a concessão de determinados medicamentos são reconhecidas, em geral, como ilíquidas, porquanto inexiste regulamentação acerca da forma de cálculo do valor dos insumos. Isso se deve, na maioria das vezes, porque o tratamento médico prescreve período longo e/ou contínuo de uso, daí exsurgindo a orientação de que o valor da causa corresponda ao custo anual do tratamento (*v.g.,* Apelação Cível, Nº 50045382220208210019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 07-10-2021).

Rejeito, portanto a preliminar suscitada.

A preliminar trazida pela ré, que aduz pedido indeterminado pela requerente, confunde-se com o mérito, e com este será analisada.

Com efeito, o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos.

Na esteira, registro que a Resolução Normativa n. 338, de 21.10.2013, que passou a vigorar em 02.01.2014, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a obrigatoriedade pelos **planos de saúde privados da cobertura de terapia antineoplásica oral para tratamento oncológico.**

XI - cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de Saúde;

XII - cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando preferencialmente as seguintes características: **(Redação dada pela Resolução Normativa DC/ANS Nº 349 DE 09/05/2014).**

Os receituários anexados pela parte autora, demonstram a necessidade de utilização do medicamento postulado na inicial evento 1, RECEIT5 e evento 1, RECEIT6 e informam que a parte autora sofre da enfermidade noticiada, conforme abaixo colaciono:

Neste gráfico pode-se ver a evolução da doença com o quadro hematológico típico de uma leucemia mieloide crônica agudizada com o aumento progressivo das células leucêmicas (blastos) até o dia 24/11/2021. Neste momento, é iniciada a medicação imatinib, Pode-se ver a progressiva e espetacular regressão das células leucêmicas a partir deste dia. O numero de blastos estava em 11.770/mm3 (subindo rapidamente) e cai agora progressivamente para 660/mm3. O normal é a ausência destas celulas no sangue da paciente. A subida rápida que vinha ocorrendo se acompanharia rapidamente da piora clinica, infiltração de múltiplos órgãos e muito possivel morte da paciente na sequencia.
O uso da droga levou a progressiva melhora clinica da paciente e redução nas células leucemias. . Imatinib esta aprovado no Brasil para tratar leucemia mieloide crônica - em todas as suas fases clinicas conforme a sua bula aprovada pela ANVISA:
Glivec é indicado para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mielóide crônica (LMC) recentemente diagnosticada, cromossomo Philadelphia positivo, bem como para o tratamento de pacientes com LMC cromossomo Philadelphia positivo em crise blástica, fase acelerada, ou fase crônica após falha ou intolerância à terapia com alfainterferona.

A justificativa da negativa do plano de saúde limita-se a afirmar que o medicamento está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da RN nº 465/2021 da ANS, contudo, a sua indicação para uso diverge da moléstia da autora tanto na bula quanto na Diretriz 64 do referido Rol, bem como não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade previstas, razão pela qual a ré alega não estar obrigada a custeá-lo. Ainda, aduz que o medicamento não possuía registro na ANVISA:

Justificativa
No tocante a solicitação do medicamento **IMATINIBE** para os dados clínicos apresentados, não restou atendida a diretriz de utilização especificadas no Rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 064 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bem como esclarecer que não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), portanto tal exclusão está em consonância com o 465/2021, art. 17.

Contudo, o laudo médico acostado aos autos, emitido pela médica que assiste diretamente à parte autora, expõe detalhadamente o histórico do quadro clínico da paciente, a qual, em 2020, teve diagnosticada **alteraçao molecular não comum na mielodisplasia – translocação t(9;22) – chamado cromossoma Philadelphia , mais típica de leucemia mieloide crônica**, esta alteração justificou uma rápida tentativa de associar imatinib ao tratamento.

Imperioso salientar que a negativa de cobertura do plano de saúde somente se justificaria se **não comprovada a necessidade do fornecimento do tratamento**, exame, procedimentos, insumos ou materiais para o tratamento da patologia de que está acometido o segurado. Além disso, a limitação do critério médico na escolha do tratamento é vedada expressamente pelo artigo 16 do Código de Ética Médica.

Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR.
1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
2.- \"É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar.\" (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013).
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes.
2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 20/09/2013)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER JAKAVI® (RUXOLITINIBE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ***A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia.*** *Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do medicamento solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079951091, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019) (grifei)*

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PREVIDÊNCIA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IMATINIB 400MG. DEMANDANTE PORTADOR DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID 10 C 92.1 – LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, LEGALIDADE E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. Tendo em vista a amplitude de cobertura definida no artigo 2º da LC nº 12.134/04, atrelada às disposições da Resolução nº 21/1979, o critério utilizado pela Administração Pública para definição dos serviços oferecidos pelo IPÊ-Saúde é o da exclusão expressa, de modo que, em princípio, todos os serviços de tratamento hospitalar ou ambulatorial curativos são custeados, exceto os expressamente excluídos. 2. Hipótese em que a médica assistente prescreveu o uso do medicamento IMATINIB 400mg, sendo que a cobertura do plano de saúde ao fornecimento do medicamento há de ser reconhecida, tendo em vista que a patologia que acomete o demandante está inegavelmente inserida na especialidade Oncologia, inexistindo vedação expressa ao custeio do fármaco que tem por finalidade o tratamento da moléstia diagnosticada. 3. Ainda que assim não fosse, resta o registro de que não cabe ao Plano de Saúde selecionar o tipo de tratamento que será coberto. Ou seja, assim como ocorre nos Planos de Saúde de natureza privada, se há previsão contratual de cobertura da patologia, não cabe ao Plano de Saúde selecionar o tipo de tratamento que terá ou não cobertura. 4. Não podem prosperar os argumentos referentes ao prejuízo orçamentário e à violação dos princípios da igualdade, legalidade e independência dos poderes, porquanto a patologia da qual padece a parte autora e o medicamento postulado estão cobertos pelo plano de saúde contratado. 5. Num ponto merece guarida a irresignação da autarquia apelante, vez que se verifica a condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial com valor elevado sendo necessária e pertinente a diminuição da quantia arbitrada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70079657490, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 12-12-2018)

Dito isso, os documentos médicos juntados com a inicial comprovam que a autora é portadora da moléstia leucemia mieloide aguda CID C92.0, com **evolução da doença para o quadro hematológico típico de uma leucemia mieloide crônica agudizada**, devido ao aumento progressivo das células leucêmicas (blastos) até o dia 24/11/2021, e que necessita uso contínuo do medicamento postulado.

Assim, a prova documental, juntada pela requerente, mostra-se necessária e suficiente para a procedência da demanda, já que a indicação do tratamento está prevista por profissional que dispõe de condições para análise da condição clínica da paciente, e **salienta a melhora do quadro com o tratamento**:

para a leucemia mieloide crônica , imatinib. O resultado inicial está sendo muito

Receituário Médico

impressionante. Ela apresenta uma progressiva melhora do quadro clínico desde novembro de 2021 - com diminuição progressiva das células malignas da circulação. O quadro anexo mostra o aceto da prescrição e a recuperação espetacular do hemograma, com desaparecimento das células malignas leucêmicas que estavam em progressão franca.
Com base neste resultado, evidentemente estamos prescrevendo a manutenção da medicação de uso continuo, enquanto nao houver evidencia de progressão de doença.
Neste momento a paciente voltou a desfrutar de uma vida normal, sem sintomas, sem necessidades transfusionais e ativa na sua vida pessoal e professional.

O uso da droga levou a progressiva melhora clínica da paciente e redução nas células leucemias. . Imatinib esta aprovado no Brasil para tratar leucemia mieloide crônica - em todas as suas fases clinicas conforme a sua bula aprovada pela ANVISA:
Glivec é indicado para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mielóide crônica (LMC) recentemente diagnosticada, cromossomo Philadelphia positivo, bem como para o tratamento de pacientes com LMC cromossomo Philadelphia positivo em crise blástica, fase acelerada, ou fase crônica após falha ou intolerância à terapia com alfainterferona.

Por oportuno, esclareço que não cabe a requerida delimitar as hipóteses de utilização do medicamento, devendo prevalecer o critério médico de qual tratamento demonstra-se adequado a enfrentar a doença apresentada. Ou seja, prevista a cobertura pelo plano de saúde para determinada patologia ou método de tratamento, descabe ao réu esquivar-se a obrigação de fornecimento da modalidade terapêutica indicada, ressaindo que o medicamento é prescrito, segundo a RN 465/2021 (ANS), exatamente para o quadro clínico que encontra-se a autora:

Imatinibe	LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda	Cromossomo Ph+ recaída ou refratária.
	LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica	Recém diagnosticada LMC Cromossomo Ph+ fase crônica; crise blástica; fase acelerada; fase crônica após falha de interferon.
	Tumor estromal gastrintestinal (GIST)	Irressecável ou metastático.
	Tumor estromal gastrintestinal (GIST)	Adjuvante do tratamento de casos ressecados de alto risco.

Colaciono registro no medicamento prescrito na ANVISA:

Consultas
ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: GLIVEC

Nome da Empresa Detentora do Registro	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	**CNPJ**	56.994.502/0001-30	**Autorização**	1.00.068-5
Processo	25351.009004/0111	**Categoria Regulatória**	Novo	**Data do registro**	01/10/2001
Nome Comercial	GLIVEC	**Registro**	100680174	**Vencimento do registro**	10/2026
Princípio Ativo	MESILATO DE IMATINIBE			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTINEOPLASICO			**ATC**	
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Ademais, denota-se do laudo apresentado, que já foram prescritos outros medicamentos, sem sucesso, com plena convicção que o médico assistente é o profissional melhor habilitado a prescrever o tratamento médico adequado:

Entre julho e setembro de 2021, feito uma nova tentativa de uso de decitabina, que não pode seguir por varias toxicidades clinicas .

Pelos motivos, tenho que satisfatoriamente comprovada a necessidade da autora em fazer uso do medicamento pleiteado, diante dos documentos acostados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA®) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. ***Fornecimento de medicamento fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia.*** *Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. Taxa Única de Serviços Judiciais. Considerando a data do ajuizamento da ação, conforme Ofício-Circular n. 060/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, aplica-se, ao caso dos autos, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/2014, o qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 5º da referida lei, bem como as orientações do Ofício-Circular n. 060/2015. Honorários advocatícios. Valor. Redução. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §8º, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios, com base no §8º do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70082552761, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 25-09-2019) (grifei)*

PLANO DE SAÚDE. IPERGS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE FORNECIMENTO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. Comprovada nos autos a adequação e necessidade do tratamento médico prescrito – quimioterapia com o fármaco Imatinibe –, por se tratar de segurado portador de leucemia mieloide crônica, não fosse inexistência de disposição a excluir fornecimento segundo normas regulamentares do plano de assistência médica, resta desprovida de

fundamento a negativa de disponibilização, impondo-se ao instituto assistencial dever obrigacional quanto ao tratamento oncológico pretendido.(Agravo de Instrumento, Nº 70077413615, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 04-07-2018)

Por fim, no que tange ao pedido de ressarcimento dos valores despendidos para aquisição do medicamento pela autora, comprovada, conforme a fundamentação retro, a necessidade do tratamento, e acostadas as notas fiscais dos valores despendidos de forma particular, mediante negativa de cobertura da ré, consigno que adequado o reembolso dos valores, a partir da solicitação administrativa, em 14/12/2021, totalizando 7 caixas, no valor de R$ 9.943,00 (nove mil, novecentos e quarenta e três reais).

Isso posto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por SONIA MARIA PALLAORO MOOJEN contra UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida e:

a) condenar a demandada ao fornecimento do medicamento IMATINIBE - GLIVEC 100mg, na quantidade imprescindível à sobrevivência da demandante, até ser sanada sua necessidade, conforme prescrição médica.

b) condenar o demandado a ressarcir a quantia despendida pela autora referente à compra do medicamento, previamente ao deferimento da tutela de urgência, a partir da solicitação administrativa, em 14/12/2021, totalizando 7 caixas, no valor de R$ 9.943,00 (nove mil, novecentos e quarenta e três reais), acrescidos de correção, pelo índice do IGPM, desde a data dos desembolsos e juros de 1% ao mês desde a data da citação, até a data do efetivo pagamento.

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em R$ 2.480,00, com base no art. 85,§8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Transitado em julgado, nada mais sendo requerido, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, Juíza de Direito**, em 14/3/2024, às 18:15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10046805015v37** e o código CRC **ce6459e0**.